

22. PRÁCTICA DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR

DURACIÓN : 02:50

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video te sumerge en la práctica de estructuración del sistema vascular, haciendo hincapié en la importancia de encontrar y hacer emerger el neutro en el paciente. Gracias a técnicas como el campo microcristalino y la inmovilidad dinámica, aprenderás a crear un entorno propicio para la curación integrando los conceptos de silencio en la sala y movilidad a nivel de los pilares diafragmáticos. La sesión también se centra en la cavidad amniótica y la importancia de la respiración primaria como aliento de vida, esencial para un enfoque terapéutico holístico. Este enfoque ofrece la oportunidad de aprender no solo cómo intervenir, sino también cómo permitir que los procesos naturales del cuerpo se desarrollen.

PRÁCTICA DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR

Vamos a buscar el **silencio** de la zona C en relación con la zona A a nivel diafragmático. Hay un punto de silencio en la sala.

Los guiaré en un momento dado. Partiremos del **neutro** y dejaremos que el neutro del paciente se desarrolle poco a poco. Nos concentraremos en el **campo microcristalino**, abarcando todo el espacio.

Para lograr la acción terapéutica más eficaz posible, es esencial alcanzar un neutro. Luego, es importante que este neutro emerja en el paciente. Es un proceso que debe **madurar**.

Para ello, se necesita el **meeting point**, el punto de encuentro. Una vez que he establecido este punto de encuentro, la persona, con confianza, puede desvincularse progresivamente, dejarse llevar e ir hacia su neutro.

Poco a poco, estos dos neutros comenzarán a mezclarse. Una vez que estos dos neutros se mezclan, puede aparecer un espacio, una **emergencia** más visible: lo que llamamos la **respiración primaria**.

La respiración primaria no solo está presente en el cuerpo, es omnipresente, un poco como el **aliento de vida**.

Nos concentraremos en la **cavidad amniótica**, esta zona B. Al mismo tiempo, disociaremos nuestra atención para enfocarnos en los **pilares diafragmáticos**.

El punto más fijo de mi diafragma está constituido por los pilares. Veremos que, finalmente, alcanzaremos un neutro. Son puntos de apoyo enormes, casi un punto silencioso.

Con un poco de paciencia, haremos emerger el neutro de manera más amplia, utilizando también el **silencio cristalino**.

Hablaremos más bien de la **inmovilidad cristalina** de la sala. Existe una forma de inmovilidad en la zona C que debemos percibir. Dejaremos que el cuerpo se centre en relación con esta zona C.

Aunque pueda parecer sutil, esto se hará naturalmente en un plano **fluídico**, casi eléctrico.

Luego, comenzaremos a confundir este silencio de la sala, o esta inmovilidad dinámica de la sala, con la inmovilidad dinámica a nivel de los pilares diafragmáticos.

Siendo conscientes de la cavidad amniótica y de la integración de mi **vesícula vitelina** para formar mi sistema venoso, vamos a confundir este silencio de la sala con la inmovilidad dinámica.

Es crucial abandonarse totalmente a la **respiración primaria**, al movimiento presente, a la marea, es decir, a la **fuerza terapéutica**, a la potencia.

Dejen que poco a poco se vea lo que esto puede generar. El objetivo, en el **no-hacer**, es no inducir, sino confiar en el osteópata.